

Drętwienie ud

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa ruchomości biodra i odcinka lędźwiowego oraz zmniejszenie drażnienia tkanek w okolicy pachwiny/uda, gdy objawy są ocenione jako mechaniczne.

Uwaga kliniczna
Drętwienie bocznej części uda może mieć inne źródło niż drętwienie przedniej lub tylnej części. Przy narastającej słabości nogi, zaburzeniu chodu lub objawach obustronnych wymagana jest ocena neurologiczna.

1 JOGA 1 Niski wykrok

Jedna noga z przodu, drugie kolano na podłożu. Delikatnie podwiń miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakrocznej.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie rób przeprostu lędźwi.

2 JOGA 2 Sfinks

Leżenie na brzuchu, podpór na przedramionach. Unieś klatkę do komfortowego wyprostu.

Dawka: 20-30 s x 2-3

Wskazówka: Wykonuj tylko, jeśli nie zwiększa drętwienia w udzie.

3 POZIOM 1 - łatwy Kołysanie miednicą w leżeniu

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Powoli przechodź między lekkim spłaszczeniem i lekkim łukiem lędźwi.

Dawka: 10-15 powt.

Wskazówka: Bez forsowania końcowego zakresu.

4 POZIOM 2 - średni Rozciąganie zginaczy biodra w półkłęku

Z półkłęku podwiń miednicę i napnij pośladki nogi z tyłu. Przesuń ciało lekko do przodu.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj do bólu lub mrowienia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył

Z pozycji stojącej cofnij jedną nogę i obniż ciało. Wróć do stania, aktywnie pracując pośladkiem nogi podporowej.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3

Wskazówka: Utrzymuj stabilną miednicę i kolano nad stopą.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.